

分子標的治療薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 経口TKIの服用時点・残薬・自己調整の確認
- ☐ CYP3A4・胃酸分泌抑制薬・食品を含む相互作用の確認
- ☐ 電話フォローで皮疹・下痢・血圧・咳を確認
- ☐ 皮膚障害のスキンケア指導と外用薬の使い方
- ☐ 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ

病院薬剤師

- ☐ バイオマーカー検査の結果とレジメンの整合性の監査
- ☐ 抗体薬・ADCの投与管理(インフュージョンリアクション対策)
- ☐ 心エコー・画像検査など定期検査の計画
- ☐ ILD等の重篤な副作用発生時の院内連携
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

病院と共有する情報

標的・治療薬

検査値

皮疹・下痢のGrade

血圧・服用状況

2 経口分子標的薬の服用時点と相互作用の要点

薬剤	服用時点・スケジュール	相互作用・注意点
エルロチニブ	空腹時(食事の1時間以上前または食後2時間以降)	胃酸分泌抑制薬で吸収↓、喫煙で濃度↓、CYP3A4
ニロチニブ	空腹時 1日2回(約12時間ごと)	食後の服用で吸収↑、QT延長、CYP3A4・グレープフルーツ
ラパチニブ	空腹時(食事の1時間以上前または食後1時間以降)	食後の服用で吸収↑、CYP3A4、下痢
イマチニブ	食後(多めの水で)	CYP3A4阻害薬・グレープフルーツ、浮腫
レゴラフェニブ	食後(高脂肪食の後は避ける)	手足症候群、投与初期の肝機能・血圧
バルボシクリブ	1日1回 21日服用・7日休薬	好中球減少、CYP3A4阻害薬
アベマシクリブ	1日2回 連日	開始早期の下痢、CYP3A4阻害薬

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	ロルラチニブ CYP3A4強誘導	処方薬 リファンピシン(抗結核薬)	重篤な肝障害・効果減弱	併用しない。他院の抗結核薬の処方を確認
注意	イマチニブ・ニロチニブ等 CYP3A4阻害	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系抗真菌薬	血中濃度↑ → 副作用↑	他院の抗菌薬・抗真菌薬の処方を確認
注意	エルロチニブ・ダサチニブ等 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬も確認、服用時間を調整
注意	経口TKI CYP3A4阻害・誘導	サプリ・食品 グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ	副作用↑・効果↓	食品・サプリの摂取を聴取
注意	ニロチニブ・オシメルチニブ QT延長の重複	処方薬 抗不整脈薬・マクロライド系等	QT延長・不整脈	併用薬と低K・低Mg血症の有無を確認
確認	血管新生阻害薬 創傷治癒遅延	処置・検査 手術・抜歯の予定	創傷治癒遅延・出血	予定を病院と共有し休薬期間を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「この薬は毎日同じ時間に飲み続けることが大切です。食事との関係もあるので、飲むタイミングを一緒に決めましょう」

確認:服用時点(空腹時・食後)、胃薬・CYP3A4関連の併用薬、サプリ

△ グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウは避ける

開始～2週

「顔や胸の発疹、下痢が出始める時期です。保湿と下痢止めを早めに使いましょう」

確認:電話フォローで皮疹・下痢のGrade、家庭血圧を確認

△ 水様便が1日4回以上増える時は連絡

1～3か月

「息切れや空咳が続く時は、次の受診を待たずに連絡してください」

確認:咳・息切れ、血圧手帳、手足の症状

△ 息切れ・空咳・発熱はILDを疑い至急受診

長期服用中

「副作用がづらい時に自己判断で減らさず、まず相談してください。量を調整する方法があります」

確認:残薬・自己調整の有無、肝機能・心機能検査の予定

△ 自己中断・減量はトレーシングレポートで共有